

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PENATALAKSANAAN PERSALINAN GANDA		
	No. Dokumen 571.11/I-SPO/MTR/VI/2025	No. Revisi 01	Halaman 1 / 5
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 18 Juli 2025	Ditetapkan Oleh : Direktur Rumah Sakit Prima Husada  dr. Nur Mazidah	
Pengertian	Persalinan ganda ialah suatu persalinan dengan dua janin atau lebih intra uterine.		
Tujuan	Ibu bersalin dengan bersih dan aman sehingga mencegah kesakitan dan kematian pada ibu dan bayi 1. Agar persalinan berjalan normal untuk kedua bayi 2. Mencegah terjadinya persalinan lama		
Kebijakan	1. Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor : 571.2/I-PDM/DIR/VI/2025 tentang Pedoman PONEK 24 jam 2. Dilakukan oleh Dokter.		
Prosedur	A. Bila ibu datang dalam keadaan belum pada fase persalinan 1. Periksa kondisi umum pasien dan tanda-tanda vital 2. Pastikan bunyi jantung janin dan letak janin. 3. Lakukan pemeriksaan USG/kesejahteraan janin, 4. Observasi tanda – tanda persalinan B. Bila Ibu datang dalam fase persalinan 1. Periksa letak kedua bayi, baik dengan palpasi / pemeriksaan dengan USG 2. Periksa bunyi jantung janin dan keadaan bayi,tentukan kesejahteraan janin 3. Bila letak bayi I 1. Presentasi belakang kepala / bokong, lakukan persalinan pervaginam sesuai syarat dan indikasi 2. Presentasi bokong / letak lintang lakukan bedah Caesar 3. Bila letak bayi II 1. Presentasi belakang kepala / bokong, lakukan persalinan pervaginam sesuai syarat dan indikasi 2. Presentasi bahu / letak lintang lakukan versi luar / versi ekstraksi, bila gagal lakukan bedah Caesar sebagai alternatif terakhir. 3. Pantau kemajuan persalinan dengan partograf C. Persiapan tindakan a. Persalinan pervaginam 1. Persetujuan tindakan medik 2. Persiapan bahan dan alat 1. Seperangkat alat persalinan normal 2. Seperangkat alat infus 3. Seperangkat alat untuk menjahit luka perineum 4. Seperangkat alat untuk resutitasi kardiopulmoner 5. Cairan infus RL, Dextrose 5 % dan Na Cl		

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PENATALAKSANAAN PERSALINAN GANDA		
	No. Dokumen	No. Revisi	Halaman
	571.11/I-SPO/MTR/VI/2025	01	2 / 5
	6. Pavidon iodine 2–3 % (diencerkan dalam larutan 10%) 7. Oksitosin dan lidocaine 2 % 8. Disposable spuit 3 cc dan 10 cc 3. Persiapan pasien 1. Pasien dianjurkan untuk buang air kecil dulu, daerah perut bawah dan lipat paha dibersihkan dengan air dan sabun (bila memungkinkan) 2. Pasien dipersilahkan untuk berbaring di tempat tidur dalam posisi lithotomi		
Prosedur	3. Pasang infus profilaksis Pasang kain alas bokong, penutup perut bawah dan kedua tungkai 4. Persiapan bayi –Minta petugas untuk menghubungi dokter anak / perawat mahir anak untuk asuhan bayi baru lahir. –Meja resusitasi dan alat bantu pengatur suhu tubuh bayi –Kain atau handuk kering yang bersih dan hangat –Seperangkat alat resusitasi bayi 5. Persiapan penolong –Pakai baju kamar tindakan, topi, masker, kaca mata pelindung , apron dan alas kaki –Cuci tangan dengan sabun sampai siku di bawah air mengalir –Keringkan dengan handuk bersih dan kering 6. Persalinan perabdominal (bedah Caesar) 1. Persetujuan tindakan medik 2. Koordinasi dengan OK dan Perinatologi 3. Persiapan bahan : – Seperangkat alat infus – Seperangkat catheter dan kantong – Cairan infus – Peralatan untuk bayi dan ari – ari bayi 4. Persiapan Pasien – Lakukan pemasangan infus – Lakukan pemasangan catheter – Lakukan pembersihan dan pencukuran rambut pubis – Mengganti baju pasien dengan baju operasi 5. Persiapan bayi – Lakukan koordinasi dengan dokter anak (perinatologi) – Siapkan meja dan alat untuk resusitasi bayi – Kain / Handuk kering bersih dan hangat		

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PENATALAKSANAAN PERSALINAN GANDA		
	No. Dokumen 571.11/I-SPO/MTR/VI/2025	No. Revisi 01	Halaman 3 / 5
	D. Tahap persalinan : 1. Kala I (kala pembukaan) 1. Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir 2. Lakukan palpasi Leopold untuk memastikan letak dan presentasi janin. Pakai sarung tangan, DTT lakukan pemeriksaan dalam untuk menyesuaikan dengan hasil palpasi. 3. Nilai kondisi kontraksi uterus dan kemajuan persalinan (buat partograf) 2. Kala II (kala pengeluaran) 1. Melahirkan anak pertama (AP) – Jika pembukaan sudah lengkap, pasien diberitahu bahwa proses pengeluaran akan segera berlangsung dan minta pasien untuk mengikuti instruksi dokter – Pada saat puncak kontraksi uterus, minta pasien untuk meneran sambil menarik lipat lutut. Bila kontraksi uterus menghilang , minta pasien untuk beristirahat dan bersiap untuk meneran bila ada kontraksi uterus berikutnya. Pimpin berulang kali hingga kepala turun ke dasar panggul		
Prosedur	– Pada saat pasien meneran, dan kepala membuka vulva serta mendorong perineum, lakukan episiotomi mediolateralis (bila diperlukan) – Lahirkan kepala, bersihkan muka, hidung dan mulut bayi, kemudian lahirkan seluruh badan bayi sebagaimana pada persalinan spontan – Serahkan bayi kepada dokter anak / perawat mahir anak yang bertugas – Istirahatkan pasien, nilai kembali kontraksi uterus dan lakukan pemeriksaan dalam ulangan untuk menilai presentasi dan posisi anak kedua (AK) 2. Melahirkan anak kedua (AK) 1. Setelah anak pertama (AP) lahir segera lakukan pemeriksaan dalam untuk menilai – Letak anak, presentasi dan penurunan AK – Keutuhan selaput ketuban – Adanya penyulit dari faktor anak (misalnya prolapsus tali pusat, gawat janin atau retensi anak kedua). Faktor pasien (misalnya Inersia uteri, kelelahan atau histeria). Faktor teknis (misalnya tidak cukup panggul, kesenjangan ukuran instrumen, bagian terbawah bayi dan sebagainya) 2. Bila anak kedua presentasi kepala		

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PENATALAKSANAAN PERSALINAN GANDA		
	No. Dokumen	No. Revisi	Halaman
	571.11/I-SPO/MTR/VI/2025	01	4 / 5
	– Tunggu kontraksi uterus kuat, tahan fundus uteri, kemudian fiksasi kepala bayi agar masuk ke dalam pintu atas panggul, kemudian lakukan amniotomi. – Bila kontraksi rahim menjadi tidak adekuat, beri drip oksitosin 5 U dalam 500 cc D5 dengan tetesan yang menghasilkan kontraksi sesuai untuk kontraksi kala II 3. Bila anak kedua bukan presentasi kepala, jika syarat memenuhi lakukan versi luar, jika berhasil lanjutkan persalinan pervaginam. Kalau gagal lakukan SC. 3. Kala III (kala Uri) 1. Segera setelah anak kedua lahir berikan oksitocin drip 10 IU dan lakukan pengosongan kandung kemih 2. Upayakan uterus berkontraksi dengan baik 3. Lahirkan plasenta dengan traksi terkontrol pada tali pusat. Bila belum berhasil, tunggu hingga tampak tanda - tanda pelepasan (separasi) plasenta – Setelah plasenta lahir, periksa kelengkapannya. Perhatikan uterus dan bila diperlukan berikan uterotonika lagi – Perhatikan perdarahan yang terjadi dan eksplorasi pada jalan lahir – Lakukan penjahitan pada luka episiotomi (bila dilakukan). Setelah selesai, nilai kembali kontraksi uterus, keluarkan darah sisa pada jalan lahir dan pasang kassa yang dibasahi dengan larutan antiseptik pada jahitan episiotomi. – Kumpulan instrumen dan bahan habis pakai ke dalam tempat yang disediakan. Bersihkan dan lepaskan sarung tangan ke dalam tempat dekontaminasi. Cuci tangan hingga lengan dengan sabun dan air mengalir lalu keringkan dengan handuk bersih dan kering.		
Prosedur	– Periksa dan catat tanda – tanda vital ibu kemudian cantumkan dalam status. Catat dan tuliskan instruksi untuk kala IV dan pemantauan lanjutan. 4. Kala IV (2 Jam PP) 1. Pantau kontraksi uterus dan jumlah perdarahan selama 2 jam pasca persalinan 2. Jika tanda vital dan hasil pemantauan menunjukkan nilai yang normal, kenakan kassa pembalut dan pakaian, kemudian pindahkan pasien ke ruang 8 Obstetri E. Dokumentasi dan pencegahan infeksi pasca persalinan F. Perawatan pasca persalinan		

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PENATALAKSANAAN PERSALINAN GANDA		
	No. Dokumen 571.11/I-SPO/MTR/VI/2025	No. Revisi 01	Halaman 5 / 5
	1. Temui pasien dan bayi (atau lihat bayi di ruang perawatan). Jelaskan proses dan hasil pertolongan persalinan serta minta pasien untuk mengikuti instruksi perawatan. 2. Buat laporan persalinan, tulis instruksi dokter, pemantauan dan perawatan lanjutan serta jelaskan pada petugas yang merawat selanjutnya.		
Unit Terkait	1. Kamar bersalin, 2. Ruang Perinatologi		